

Projektplan for **Tematillæg til Ugeskrift for Læger**

Indhold

Projektbeskrivelse: Tankerne bag, og baggrunden for	2
Formål	3
Mål	3
SMART	3
Succeskriterier	4
Projektorganisation	4
NABC	5
Indsatsområder og delmål	5
Milepæle	6
Tidsplan	7
Interessent- og målgruppeanalyse	8
Interessentkommunikationsplan	9
Ressourceforbrug	10
Risikoanalyse	12
Evaluerings af produktet	12
Evaluerings af processen	13
<i>Refleksionsrapport</i>	<i>15</i>

Projektplan for

Tematillæg til Ugeskrift for Læger

Projektbeskrivelse Tankerne bag ...

Ugeskrift for Læger har tidligere haft forskellige tillæg med blandet succes. Disse tillæg har oftest været styret af én journalist med en god idé til et emne. Der har alene været tale om korte journalistiske artikler om det pågældende emne. Derudover optræder der videnskabelige temanumre af Ugeskriftet, hvor en del af de videnskabelige artikler er inden for det samme emne.

Jeg forestiller mig, at sætte gang i en ny form for tematillæg, der indeholder både journalistisk og videnskabeligt stof samt evt. input fra forskellige organisationer eller selskaber – altså et aktuelt emne der vinkles fra alle mulige sider. Der skal være plads til både længere og kortere artikler, interviews, synspunkter og holdninger fra alle tænkelige dele af lægeverdenen.

Jeg har valgt at tillægget skal ligge på Ugeskriftet.dk for at spare penge til trykning og distribution, men også fordi elektronisk publicering har så mange muligheder som tryk ikke har.

Her tænker jeg især på muligheden for en levende debat – der er lukket og kun for læger – men også på video og lyd samt muligheden for løbende at supplere med nye artikler. Desuden har man mulighed for at linke til andre lægefaglige tidsskrifter ude i verden.

... Og baggrunden for

Som baggrundsmateriale for projektet har jeg brugt en Gallupundersøgelse som Ugeskrift for Læger fik foretaget i sommeren 2013. Undersøgelsen er foretaget blandt 1.217 repræsentativt udvalgte medlemmer af Lægeforeningen, vejet på køn, alder og medlemsorganisation (Praktiserende læger, Yngre læger, Speciallæger, Overlæger).

Her udover har jeg brugt referaterne fra to fokusgruppeinterview der blev afholdt i henholdsvis Aarhus og København i foråret 2013.

Både Gallupundersøgelse og fokusgruppeinterviews kommer bredt omkring hele Ugeskriftet såvel på tryk som på web. Gallupundersøgelsen indeholder dog ikke materiale omkring temanumre, så der må jeg alene forholde mig til udsagnene i fra fokusgrupperne.

Jeg fokuserer på lægernes holdning til debat og temanumre, men også på holdningen til trykt medie vs. digitalt medie samt brugernes aldersfordeling.

På spørgsmålet »Læser du Ugeskriftet på tryk« svarer ca. 94% af lægerne læser at de læser Ugeskriftet på tryk. Hvis man pinder det lidt mere ud og ser på aldersfordelingen er der 86% af de 60+ årige der læser Ugeskriftet på tryk hver gang eller tre ud af fire gange, mens for gruppen op til 39 år kun ligger på 64%.

Hvis man kigger på de tilsvarende tal for Ugeskriftet.dk er det kun ca. 51% der bruger ugeskriftets hjemmeside. Men lidt overraskende er der stadig en overvægt af ældre brugere; 67% af de 60+ årige bruger hjemmesiden dagligt/flere gange ugentligt eller ugentligt. For gruppen op til 39 år er det kun 45% der svarer det samme.

Der er pr. 1. januar 26.669 medlemmer af Lægeforeningen. Af dem er knap 8.000 under 39 år mens kun 4.800 af medlemmerne er 60+.¹

70% af alle lægerne er enige eller delvist enige i udsagnet: »Debatstof i Ugeskrift for Læger er interessant for mig«. (Der er nogenlunde ligeligt fordelt i alle aldersgrupper).

I fokusgruppeinterviewsne er der mange tilkendegivelser om bedre og mere skarp debat og debat der er lukket og kun for læger.²

Ligeledes er der mange positive kommentarer over for temanumre. Der er en af fokusgruppedeltagerne der formulerer sig således med hensyn til temanumre: »... godt at folde emner ud og komme hele vejen rundt«, og det er i virkeligheden det jeg har forestillet mig; at der vælges nogle emner ud som vendes og drejes.

Det ser ud til, at det er de yngste læger vi har dårligst fat i. Der er mange af dem, og de udgør en hastigt voksende del af den danske lægestand – det myldrer ud af universiteterne med meget unge læger i disse år. En stor andel af de nyuddannede læger, er kvinder under 30 år og de er meget målrettede både med hensyn til karriere og til familie, og tid er en vigtig faktor for dem. Information skal være præcis og tilgængelig hvor som helst og når som helst. Dette går godt i tråd med et tematillæg der lever på internettet, som jo efterhånden er tilgængeligt mere eller mindre når som helst og hvor som helst.

Da det er gruppen af de yngste læger der bruger mindst til på såvel Ugeskriftet på tryk som på web, er det vigtigt især at fokusere på denne gruppes ønsker.

Formål

Formålet med projektet er at efterkomme nogle af lægernes ønsker med hensyn til temaer der går i dybden med et emne inde for lægeverdenen, samt at gøre det mere tilgængeligt for lægerne at debattere og dele viden og erfaringer.

Formålet er også at få flere af de yngste læger til at bruge lidt mere tid på Ugeskriftet, og en god indgangsvinkel til dette vil være en netbaseret tema-debat side på Ugeskriftet.dk.

Mål

Fremover kommer der årligt tre tværfaglige og debatskabende tematillæg på Ugeskriftet.dk

SMART

Målet er SMART:

Specifikt: Et tematillæg der behandler aktuelle emner og som giver mulighed for deltagelse via debat. Da tanken er, at der skal komme flere tillæg løbende, skal der være et område på Ugeskriftet.dk til tematillæg.

Målbart: Man vil kunne måle trafikken og sidevisningerne tematillæggene på hjemmesiden. Men man vil også have en idé om succesraten ved at se på tilslutningen til debatten.

1. www.laeger.dk > Om Lægeforeningen > Lægeforeningen i tal.

2. For at læge og deltage i debatten på Ugeskriftets hjemmeside skal man være logget ind med sit medlemsnummer til Lægeforeningen. Der er mange der gerne vil deltage i den faglige debat, men holder sig lidt tilbage af frygt for hvem der læser med. I et lukket forum vil der formentlige være en mere fri debat.

Ambitiøst: Det ambitiøse eller nytænkende i projektet ligger i at tillægget alene lever på nettet, og som sådan ikke udspringer af det trykte blad.

Realistisk: Projektet er realistisk, da de enkelte dele er prøvet før (videnskabelige temaer og journalistiske tillæg) og med afsæt i lægernes ønsker, Ugeskriftets unikke videnskabelige artikler og vores nye hjemmeside er det muligt. Desuden vil opgaverne med projektet ikke være fremmedartede for projektdeltagerne.

Tidsfast: Der er ikke sat en dato på projektet, da vi har nogle begyndervanskeligheder med vores nye hjemmeside, som jeg synes det vil være praktisk at have styr på inden man kaster sig ud i et projekt der forankres på den platform, men projektet kan i teorien rulles ud når som helst.

Succeskriterier

- Der skal være 5.000 unikke brugere på tematillægget i løbet af de første 14 dage.
- Der skal være mindst ti artikler med kommentarer/debat inden for de første 14 dage.
- Ved næste Gallupundersøgelse skal der spørges specifikt til tematillæg, og der skal være mindst 60% af de adspurgte der tilkendegiver at de benytter/læser tematillæg i et rimeligt omfang.

Projektorganisation *Styregruppe:* Jeg mener ikke at der i dette projekt er behov for en styregruppe.

Projektejer: Projektejeren i dette projekt vil være chefredaktøren på Ugeskrift for Læger. Han er den, der har det overordnede ansvar for det der publiceres i/på Ugeskriftet, og den der har, eller har adgang til, viden og informationer der kan have betydning i løbet af projektet.

Han kan gå hen og blive en flaskehals i projektet, da han ikke altid er lige tilgængelig. Der bør derfor være en der kan tage ejerskab af projektet når chefredaktøren ikke er tilgængelig. Det kan enten være projektlederen eller den journalist der plejer at overtage ansvaret, men kun hvis hun i forvejen er en del af projektet – ellers vil det ikke være hensigtsmæssigt!

Projektleder: Da ideen til projektet er min, og da jeg kender til arbejdsgange, medarbejdere og produktion, vil jeg mene at jeg er den oplagte projektleder på dette projekt.

Projektgruppen: Projektgruppen vil bestå af en sekretær, en eller flere journalister, en person fra den videnskabelige redaktion (ikke nødvendigvis den videnskabelige redaktør) og projektlederen.

Ressourcepersoner: På et tidspunkt i forløbet vil det nok være en god idé at inddrage en af grafikerne til en sparring. Jeg regner ikke med at tematillægget skal have helt nyt layout i forhold til Ugeskriftet, så derfor mener jeg ikke at grafikerne skal være en del af projektgruppen.

Jeg mener heller ikke at korrekturlæserene skal være en del af projektgruppen. Deres bidrag til projektet er naturligvis vigtigt, men det er ikke noget der kan bidrage med nyt til projektet eller ændre på det. Jeg vil se dem mere som en slags ressourcepersoner.

NABC

Need: Det er vigtigt at Ugeskriftet tilbyder lægerne et unikt produkt, da Ugeskriftet er afhængigt af lægerne som læsere/brugere såvel som forfattere.

Hvis Ugeskriftet som helhed ikke udvikler sig løbende og i takt med lægernes ønsker vil lægerne søge at publicere deres viden i andre udenlandske tidsskrifter – her er fx British Medical Journal en vigtig konkurrent.

Lægerne er gennem Gallupundersøgelse og fokusgruppeinterviews blevet spurgt til deres læsevaner og ønsker, og ud af det kan vi se at blandt andet forbedring af hjemmeside, dybdegående temaer og god debat er på ønskesedlen.

Approach: Den bedste måde at efterkomme lægernes ønsker er at skabe et tematillæg der findes på Ugeskriftet.dk. På den måde kan man efterkomme lægernes ønske om tematillæg, mere kvalitet på hjemmesiden og en lettere tilgang til at debattere.

Benefit: Ideen med et tillæg der udelukkende ligger på Ugeskriftet.dk er ny i forhold til hvad man har forsøgt sig med tidligere. Desuden er det nyt at tænke bredt i forhold til at inddrage flere forskellige typer af indhold.

Og endelig vil det også være nyt i forhold til at kunne debattere direkte på det forskellige indhold på hjemmesiden. Hvis vi får debatten til at fungere, bliver lægerne gjort til brugere og ikke bare forbrugere!

Competition: Den eneste reelle konkurrent på det danske marked er Dagens Medicin, der dog ikke har det videnskabelige stof, så ved at inddrage det i Ugeskriftets tillæg vil man have noget unikt.

Der kan være konkurrence fra udenlandske medicinske tidsskrifter – fx The Lancet, der har nogle faste temaer, der kører som selvstændige elektroniske magasiner, men det vil så være uden lokalt stof.

**Indsatsområder
og delmål**

Jeg har delt projektet op i fem indsatsområder:

Indsatsområde 1: Ideen skal sælges

Indsatsområde 2: Det videnskabelige stof

Indsatsområde 3: Det journalistiske stof

Indsatsområde 4: Bidrag fra organisationer/selskaber

Indsatsområde 5: Layout, produktion og publicering

Det første indsatsområde må være at få projektet »solgt« til produktionsansvarlige, chefredaktør og videnskabelig redaktør, der tager beslutninger om indhold og økonomi i forhold til Ugeskriftet.

Når ideen er solgt skal det besluttes om det er redaktørerne der bestemmer emnet, eller om det skal lægges ud til lægerne at komme med input og ideer. Jeg vil tro at det mest realistiske er at redaktørerne vælger et emne til det første tematillæg, og måske derefter lægger op til at lægerne kan komme med ideer. Derfor har jeg valgt at gå ud fra, at redaktørerne vælger et emne.

Herefter kommer indsatsområderne 2, 3 og 4 der vedrører indhold til tillægget. De kører sideløbende og er ikke afhængige af hinanden, men har forskellige milepæle undervejs. Hver især har det delmål at få det forskellige materiale i hus.

Slutteligt er der indsatsområde 5, der er færdiggørelsen – dvs. layout og endelig upload til hjemmesiden samt »offentliggørelse« fx via det ugentlige nyhedsbrev og teaser i det trykte Ugeskrift. Når alt materiale er endeligt klar til publicering, er alle delmålene nået.

Milepæle

Milepæl for indsatsområde 1:

Der er ikke nogen egentlige milepæle i indsatsområde 1. Når ideen er købt og et emne er besluttet, er det første delmål nået.

Milepæle for indsatsområde 2:

1. Afhængigt af emnet kan der være lidt forskellige scenarier for det videnskabelige stof, men der skal findes egnede artikler i Manuscript Central³ og det skal overvejes hvor mange af artiklerne der skal have koblet en leder på. Milepælen er nået når videnskabelige redaktør og/eller assisterende videnskabelige redaktører har udvalgt de ønskede artikler og besluttet hvem der skal inviteres til at skrive ledere og til hvad.
2. Relevante personer er spurgt og har takket ja til at skrive en leder.
3. Ledere er modtaget. Det kan godt tage adskillige uger at få den slags i hus, og det kræver lidt benarbejde fra sekretærernes side!
4. De videnskabelige artikler og ledere er i hus, og der er læst korrektur.

Delmål for indsatsområde 2: Det videnskabelige materiale er klar til layout.

Milepæle for indsatsområde 3:

1. Der foreligger en ret detaljeret plan over hvilke artikler der skal skrives og af hvem. Samt aftaler med fx fotograf og artiklernes nøglepersoner.
2. Milepæl er når artiklerne er skrevet og billeder er modtaget og der er læst korrektur.

Delmål for indsatsområde 3: Det journalistiske materiale er klar til layout.

Milepæle for indsatsområde 4:

1. Chefredaktør og videnskabelig redaktør beslutter hvilke input man ønsker udefra. Det kan være fra patientforeninger, andre faggrupper, medicinske selskaber eller interesseorganisationer. Måske skal andre udenlandske tidsskrifter kontaktes med henblik på at henvise til relevante artikler her. Milepælen er nået når der ligger en plan for hvad man ønsker af eksterne input.
2. Relevante selskaber m.m. er inviteret til at komme med artikler og har tilkendegivet om de ønsker at deltage.
3. Materiale er modtaget og der er læst korrektur.

Delmål for indsatsområde 4: Materiale fra selskaber og organisationer modtaget og klar til layout.

3. Manuscript Central er et online system der bruges af tidsskriftredaktører til at holde styr på artikler i produktion. Det er lægen selv der uploader sit manuskript til systemet, og herefter bliver det peer-reviewed og godkendt (eller afvist) af redaktionen.

Milepæle for indsatsområde 5:

1. Alt materiale er afleveret til layout.
2. Alt er layoutet og klar til publicering på hjemmesiden. Teaser er klar til det trykte Ugeskrift og til det elektroniske ugebrev.

Delmål for indsatsområde 5: Alt materiale er klar til publicering på Ugeskriftet.dk.

Tidsplan

Tidsplanen er opdelt i uger, men uden datoer, da jeg som nævnt ikke ved hvornår projektet skydes igang.

Projektet strækker sig skønsmæssigt over ni uger, og herefter er det første tema klar til publicering på Ugeskriftet.dk. Da Ugeskrift for Læger fra 2014 kun kommer på tryk hver fjortende dag, vil det være en god idé at præsentere til tematillæg i en af de ulige uger hvor der ikke forligger et trykt blad.

Uge	Beskrivelse	Ansvarlig
Uge 1	Ideen præsenteres for produktionsansvarlige (økonomiansvarlige) og chefredaktør. Hvis de er med på ideen præsenteres den også for den videnskabelige redaktør.	Projektleder
	På det førstkomende videnskabelige redaktionsmøde præsenteres projektet for den videnskabelige redaktion og sekretariatsleder/webredaktør. Der brainstormes på egnede emner.	Chefredaktør og Projektleder
Uge 3	Chefredaktør og videnskabelig redaktion har fundet et egnet emne. Der skal findes egnede videnskabelige artikler i Manuscript Central.	Chefredaktør og Videnskabelig redaktør
	Der skal findes egnede forfattere til ledere til de forskellige artikler.	Videnskabelig redaktion
	De eksterne selskaber og organisationer, der skal inviteres til at bidrage er fundet og kontakttet.	Chefredaktør og Sekretær
Uge 4	Det er besluttet hvad der skal med af videnskabelige artikler, hvilke der skal have tilknyttet en leder og hvem der skal skrive lederne. Dette sættes i gang.	Videnskabelig redaktør og Sekretær
	Det er besluttet hvilke vinkler der skal belyses journalistisk, og hvilke journalister der skal bidrage med hvad. Dette sættes i gang.	Chefredaktør
Uge 7 (måske 8 ⁴)	Alle artikler er i hus og korrekturlæst. Alt leveres til layout – det kan evt. ske løbende.	Projektleder
Uge 9 (måske 10)	Alt er layoutet og endeligt godkendt til publicering. Teaser til hjemmeside, elektronisk nyhedsbrev og trykt Ugeskrift ligger klar.	Projektleder og Chefredaktør

4. Der er meget lang produktionstid på videnskabelige artikler, da de blandt andet skal peer-reviewes af tre forskellige bedømmere inden de endeligt godkendes af den videnskabelige redaktion. Dette kan til tider være en langsommelig procedure, og det kan måske være nødvendigt at lægge en ekstra uge ind her. Det er man nødt til at bedømme gang til gang.

Interessent- og målgruppeanalyse

Målgruppen til tematillæg på Ugeskrift for Lægers hjemmeside er som udgangspunkt alle læger, men jeg kunne godt tænke mig at få fat i de yngste læger, da de er dem der mindst benytter Ugeskriftets tilbud. Erfaringen viser at de ældre læger nok skal følge med hvis man ændrer på noget eller introducerer noget nyt – de brokker sig måske, men de forsvinder ikke!

Men hvem er lægerne så, og hvordan adskiller de yngre sig fra de ældre?

Jeg vil nok placere lægerne som helhed under det blå segment i Minervamodellen. Der er mennesker med høj uddannelse og højt ambitionsniveau. De vægter karriere, løn og luksus til dem selv og deres familie. Traditionelt set er der mange i det blå segment, der stemmer på Konservative eller Venstre, men her adskiller lægerne sig en smule. Således tilkendegav 25% af lægerne i en rundspørge op til valget i 2011, at de ville at de ville stemme Radikalt, og flere ville stemme Socialdemokratisk end Venstre.⁵

Mange af de nyuddannede læger er under eller omkring 30 år. De er meget fokuserede og målrettede, har høje karakterer gennem hele deres uddannelsesforløb, og højt ambitionsniveau både for lægegerningen og familie- og fritidsliv.

Lægerne er ikke bange for store og tunge tekstmængder – det er man opdraget med gennem studiet. Og er en artikel relevant, bliver den også gransket og gemt. Jeg tror dog at det er vigtigt at være så kort og præcis som mulig, så det er overskueligt for lægerne at vælge ud hvad de vil læse. Det ville være en god idé at have en leder eller intro til de videnskabelige artikler, så lægen hurtigt kan orientere sig om de lange artiklers indhold.

Jeg tror det vil være svært, at vælge et emne som man kan sige interesserer de yngste læger mere end de ældste læger. En af de ting vi ved at de nye og yngste læger lægger vægt på, er, at den viden de har brug for lige her og nu er tilgængelig og præcis – ikke så meget udenoms tidsspilde. Dvs. at man nok i første omgang skal fokusere mere på tematillæggets opbygning end på emnet for at nå ind til de yngste læger.

Interessenter	Hvorfor interesseret?	Ønsker og forventninger	Betydning, indflydelse	Problemer, udfordringer og indsatser
Læsere/læger	Vil gerne være up to date. Vil gerne have noget for pengene.	Forventer ny(este) viden og gerne nemt tilgængeligt. Ønsker reportager og debat med »kant«.	Indirekte betydning for projektet da de er modtagere, men ikke den store praktiske indflydelse undervejs i projektet.	
Produktionsansvarlige	Har ansvaret for Ugeskriftets budget og økonomi.		Kan bremse projektet eller nedjustere fra start, hvis der ikke er penge til det.	

Fortsættes

5. »Danske læger ønske ny regering« Lars Igum Rasmussen, Ugeskrift for Læger nr. 37/2011.

Fortsat

Interessenter	Hvorfor interesseret?	Ønsker og forventninger	Betydning, indflydelse	Problemer, udfordringer og indsatser
Chefredaktør	Vil gerne stå med et stærk brand. Vil gerne opfylde og imødegå læsernes ønsker.		Stor betydning for gennemførelse af projektet. Stor indflydelse på indholdet.	
Videnskabelig redaktør	Altid ønske om at publicere en stor mængde fagligt stof.	Vil ønske at der er mere fokus på det videnskabelige stof end det andet.	Stor betydning for gennemførelse af projektet. Stor indflydelse på indhold.	
Forfatter (videnskab)	Altid et ønske om at få sit navn på tryk ...	De vil forvente rigtig god tid til at levere deres artikler.	Nødvendige i forhold til at få videnskaben med.	Skal holdes til ilden af sekretærer, da de ellers overskrider deadlines.
Journalister	Spændende at arbejde med noget der ikke ligger inden for de vanterammer.	Forventer god tid.	Betydning og indflydelse på en stor del af indholdet.	Vil have svært ved at overholde deadlines og evt. skrivelængder.
Web-redaktør og sekretariatsleder	Vil gerne have en hjemmeside med mange tilbud og muligheder for læserne.	Forventer et funktionelt resultat mere end et »pænt« resultat. Kan brokke sig over mere arbejde til sekretærerne.	Indirekte indflydelse på projektet da vedkommende til en hvis grad styrer sekretærer og hjemmeside.	Bør nok have en eller anden del i projektet, for ikke at kværulere for meget!
Sekretærer	Vil muligvis føle at de skal udføre ekstra arbejde.		Ingen indflydelse på projektet. Nødvendige til at holde styr på fx forfattere.	
Korrektur-/sproglæsere	Vil føle at de skal udføre ekstra arbejde.		Indflydelse på indholdets kvalitet.	Vil brokke sig over manglende tid. Skal nurses jævnlige.
Fotografer	Da vi kun bruger freelancere er der som regel ingen problemer... De vil mægtig gerne have opgaver.		Inge egentlig indflydelse.	
Grafikere	Vil gerne levere noget »lækkert« hvor de selv har stor indflydelse.	Forventning/ønske om især god tid og godt billedmateriale.	Stor betydning og indflydelse på udformning og layout.	Vil klage over de deadlines der ikke bliver overholdt.

Interessent-kommunikationsplan

Lægerne, der er modtagere, bliver ikke involveret fra starten, men på længere sigt vil jeg lægge op til at lægerne inddrages i for eksempel ideer til emner og artikler.

Der er selvfølgelig en lille del af lægerne, der er bidragsydere og dermed er involveret direkte i projektet.

Når det første tematillæg er publiceret, vil det være oplagt at få feedback og ideer fra lægerne. Det kan gøres via hjemmesiden eller via det elektroniske ugebrev. Endvidere kan man have en artikel i det trykte blad, der beskriver tanker og ideer fra redaktionens side og lægger op til lægernes input. Det er sekretærer og journalister der står for nyhedsbrevet, og det vil også være dem der kan sørge for at få et budskab ud til lægerne.

Alle, der direkte yder noget til projektet, skal informeres og involveres løbende. Jeg kunne forestille mig at chefredaktøren informerer alle interne projektdeltagere (sekretærer, journalister, korrekturlæsere) på et af vores fællesmøder. Herefter informerer sekretærerne forfattere og selskaber.

Det vil være mig der informerer grafikere og korrekturlæsere og evt. journalister efterfølgende.

Det er vigtigt for mig, at der løbende informeres om projektet til dem der arbejder på det. Intern kommunikation er desværre ikke vores spidskompetence, så det kunne jeg godt tænke mig blev bedre med dette projekt. Det vil være mit ansvar løbende at informere alle projektdeltagere, men også redaktørerne.

Der kan gives en fælles overordnet status på projektet på vores fællesmøder. Hvad enten der er nyt eller ej, bør det gives en kort status, så medarbejderne ikke får følelsen af manglende kommunikation.

Til slut i forløbet informeres læserne om tematillægget via Ugeskrift for Læger, nyhedsbrev m.m.

Ressourceforbrug

Da det meste af arbejdet vil ligge hos Ugeskriftets egne ansatte, vil den største udgift være tid. Neden for har jeg forsøgt at redegøre for de forskellige projektdeltageres tidsforbrug.

Videnskabelig redaktør/assisterende videnskabelig redaktør

Den videnskabelige redaktion holder møde en gang om ugen, hvor nye artikler antages eller afvises. De antagne artikler tages ud til produktion. Det går på skift mellem de assisterende redaktører at have ansvaret for et Ugeskrift. Et gennemsnitligt Ugeskrift indeholder ti videnskabelige artikler og to ledere. Det bruger redaktøren 5 timer på.

Journalister

Alt efter budgettets størrelse kan man fx være nød til at overveje om der i en periode kan slækkes lidt på antallet af nyhedsartikler på hjemmesiden til fordel for, at der skrives artikler til projektet. Alternativt må der købes artikler fra freelancere til Ugeskriftet og/eller til projektet.

Artikler fra egne journalister	25 timer pr. artikel
Artikler fra eksterne journalister	7.500 kr. pr. artikel
Fotograf	800 kr. pr. time (i gennemsnit 3 timer pr. opgave)

Sekretærer

Sekretærstaben vil skulle bruge en del tid på korrespondance og administrativt arbejde i forbindelse med artiklerne og forfatterne, samt kommunikation med eksterne selskaber. De vurderer selv at de bruger ca. 1 time fra start til slut på videnskabelige artikler og 15 min. på en journalistisk artikel. Jeg vil tro at artikler der kommer fra eksterne selskaber tidsmæssigt vil ligge et sted der imellem.

Sekretærer	1 time pr. videnskabelig artikel
	0,25 time pr. journalistisk artikel
	0,5 time pr. selskab/organisation

Chefredaktør

Chefredaktøren skal bruge tid på redaktionsmøder op på at gennemgå det journalistiske materiale samt materiale fra de eksterne selskaber m.m.

Han deltager oftest ca. 30 minutter i de ugentlige videnskabelige redaktionsmøder og så holder han og journalisterne ca. 1 times redaktionsmøde om ugen. Et tematillæg vil nok kræve 30 minutters ekstra redaktionsmøder om ugen for chefredaktøren.

Redaktionsmøder	0,5 time pr. uge
Gennemlæsning af manuskripter	0,25 time pr. artikel

Korrektur og sprog

Her kan formentlig slækkes lidt på antallet af »almindelige» videnskabelige artikler der læses i en periode, så der bliver tid til tema-artiklerne. De videnskabelige artikler bliver både læst i korrektur og sprog – altså to gange. Det øvrige materiale læses kun i korrektur.

Videnskabelige artikler korrektur	0,75 time pr. artikel
Videnskabelige artikler sprog	0,75 time pr. artikel
Øvrige artikler	0,5 time pr. artikel

Projektleder

Jeg vil som projektleder også skulle bruge en hel del timer på planlægning, information, og kommunikation, og som tovholder gennem projektet.

Der vil være mere eller mindre arbejdstunge perioder i forløbet. I opstartsfasen og når materialet kommer i hus og sendes videre til layout, vil jeg ganske givet bruge et par timer om dagen, mens jeg formodentlig kun vil bruge et par timer om ugen mens produktionen er i gang. Desuden bliver det nok også mig, der i sidste ende skal sørge for at alt bliver uploadet til hjemmesiden.

Opstartsfasen (Uge 1)	8 timer
Journalister og eksterne selskaber er i gang (Uge 4)	10 timer
Materialet kommer i hus og skal samles og videre til layout	10 timer
Øvrige uger	3 timer/uge = 15 timer
Upload til hjemmesiden	5,5 timer

Og så må man hellere lægge 10% oven i, da der altid er uforudsete hændelser, som tager tid at løse.

Samlet tid for projektleder	53,5 timer.
-----------------------------	-------------

Layout og færdiggørelse

Jeg er gået ud fra at layoutet på tematillægget lægger sig tæt op ad Ugeskriftets layout. Det har noget at gøre med hvad vores produktionsstyringssystem er sat op til at håndtere i forhold til tryk og web. Det indebærer desværre en del begrænsninger, og det vil kærve enorme ressourcer og tid at ændre på nuværende tidspunkt.

Jeg er også gået ud fra at det er vores sædvanelige leverandør, der står for layout.

Layout og sats af 48 sider	43.200 kr.
----------------------------	------------

Risikoanalyse

Jeg mener ikke, at der kan opstå så mange voldsomme problemer undervejs! Når først chefredaktør og videnskabelig redaktør har købt ideen og den er sat i gang, vil det formentlig køre fint.

De involverede parter skal langt hen ad vejen løse opgaver der ligner det de er vant til.

Med hensyn til deadlines der overskrides sent i forløbet, har jeg ikke vurderet sandsynligheden som ret stor, men hvis det sker, er det til gengæld et stort problem. Det er noget jeg er nødt til at være meget opmærksom på, så jeg kan nå at sætte ind, hvis tingene begynder at trække i den retning. Jeg mener at man har et troværdighedsproblem overfor sine læsere, hvis man lover at lancere noget nyt og så ikke gør det alligevel.

Muligt problem	Konsekvenser (målt på en 1-5 skala)	Sandsynlighed (målt på en 1-5 skala)	Værdi	Indsats/hvad gør vi?
Deadlines overskrides (tidligt i forløbet)	2 Projektet står og falder ikke med mindre tidsoverskridelser tidligt i forløbet.	5 Erfaringsmæssigt vil der være overskredne deadlines.	10	Man må prøve at holde snor i journalister undervejs. Forfatterene skal jævnligt følges op/ huskes på og evt. rykkes. Deadlines overskrides
Deadlines overskrides (sent i forløbet)	5 Hvis flere vigtige artikler ikke er klar ved deadline kan det ende med at rykke udgivelsesdatoen	1 Enkelte artikler kan være forsinkede, men det ender som regel med at det hele er klar i sidste øjeblik!	5	Hvis man er nødt til at rykke udgivelsen skal de ske inden der er reklameret i det trykte blad.
Dårlig stemning over øget arbejdsmængde/ tidspres	3 Dårlig stemning har det med at sprede sig. Hvis der er dårlig stemning om et projekt, bliver det sværere og sværere for de involverede at yde et godt stykke arbejde.	3 Erfaringsmæssigt vil nogle af journalisterne blive sure og det kan hurtigt smitte af på andre. Korrekturlæsere vil formentlig også brokke sig i et vist omfang.	9	Anerkende at de involverede arbejder hårdt. Bevare optimismen og tilbyd at hente en kop kaffe. (Det plejer faktisk at virke meget godt...!) Kan andre opgaver midlertidig vente eller flyttes til andre?

Evaluerings af produktet

Det færdige produkt – det første tematillæg – skal naturligvis evalueres af lægerne, da det er her projektets virkelige succes (eller mangel på samme) kan aflæses.

Det er oplagt at bruge kvantitativ evaluering på tematillægget. Man vil fx kunne få et ganske lille spørgeskema til at poppe op når læserne trykker sig ind på tematillægget. Det skal endelig ikke være stort og uoverskueligt, da der så er for mange der ikke gider at udfylde det. På denne måde vil man løbende få respons på det man har lavet. Her ville det også være muligt at have et felt hvor der kan skrive ønsker og ideer til nye temaer.

Når vi næste gang får foretaget en Gallupundersøgelse af Ugeskriftet, kunne man vælge at bruge et par spørgsmål på tematillægget og på den måde få et mere nuanceret billede dels af lægernes holdning til tillægget.

I en Gallupundersøgelse ville jeg spørge til følgende:

- Hvor ofte læser/bruger du tematillæg på hjemmesiden?
- Hvor læser/bruger du tematillæg på hjemmesiden (iPad, computer, smartphone, andet ...)?
- Deltager du selv i debatten på tematillæg?
- Hvor tilfreds er du med tematillæg på hjemmesiden?

Det ville kunne give et billede af lægernes tilfredshed med mit produkt. Gallup-undersøgelsen er stillet op så man kan se fordeling på alder, køn og tilhørsforhold ved hvert spørgsmål.

Endelig kan man også vælge kvalitativ evaluering og spørge vores fokusgrupper om deres holdninger og synspunkter til tillægget. Jeg ved dog ikke hvornår det er tanken at foretage fokusgruppeinterview igen, og jeg synes heller ikke at det vil være en evalueringsmetode der kan stå alene.

Evaluering af processen

Da projektet endnu ikke er gennemført er det svært at evaluere det, men følgende er mine tanker om, hvordan man kunne evaluere, med hvem og hvilke spørgsmål der bør stilles og besvares i evalueringen.

Hvis alt er gået efter planen vil jeg tage den interne evaluering i projektgruppen på et uformelt møde, hvor de involverede kan diskutere hvordan projektet er forløbet. Hvis det mod forventningerne ender med at alting falder på gulvet og projektet bliver noget møg, skal evalueringsmødet være mere formelt. Alle i projektgruppen skal på forhånd tænke over og skrive ned, hvad de mener kunne være håndteret anderledes og hvad de hver især mener er den største grund til at projektet gik galt, hvordan har kommunikationen været og hvordan har gruppen fungeret.

Selvom projektet skulle gå forrygende og uden problemer, tror jeg også det er vigtigt, at sætte sig lidt ud over sig selv og se på sin egen bedrift. Der er helt sikkert ting man selv kunne have gjort lidt bedre, og det er værd at have tænkt over til næste gang ...

Helt konkret skal der evalueres på de forskellige indsatsområder i processen:

- Det videnskabelige stof
- Det journalistiske stof
- Det eksterne stof
- Færdiggørelsen

For hver af disse områder skal der spørges til:

- Nåede vi det ønskede delmål til tiden? – Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hvilke dele af processen fungerede godt, og hvilke fungerede mindre godt?
- Hvad har vi erfaret som vi kan drage nytte af næste gang?

Mere overordnet til hele projektet skal der spørges til:

- Blev tidsplanen overholdt?
- Blev budgettet overholdt?
- Hvordan fungerede kommunikationen?

- Skal projektgruppen til næste tillæg bestå af de samme personer – skal der være flere eller færre?

Når der er gået nogle uger efter publiceringen vil man også kunne se på om succeskriterierne er nået på tilfredsstillende vis. Har vi fat i brugerne – er der mange sidevisninger og gang i debatten? Skal man evt. *booste* debatten lidt ved at invitere nogle af lederskribentene til at »provokere« lidt?

For hver gang der kommer et nyt tematillæg på siden skal der foretages en evaluering. Er der noget der kan gøre bedre? Hvor skal der strammes op?

Og endelig: Når den næste Gallupundersøgelse foreligger, kan man se hvorvidt man er nået ud til målgruppen – især de yngste læger.

Reflektionspapir

for projektet: Tematillæg til Ugeskrift for Læger

Egne refleksioner

Den allerførste tanke jeg gjorde mig i forbindelse med mit projekt, var at jeg måtte vælge et noget som jeg ville føle mig tryk ved, og som jeg kunne relatere til. Så da jeg har været grafiker i mange år, og primært arbejdet med trykte medier, valgte jeg, at mit projekt skulle være et trykt 24-siders tillæg til Ugeskrift for Læger.

Men efter hånden som jeg arbejdede med dette projekt, kunne jeg godt se at det ikke var et særligt godt projekt. Det er dyrt at trykke og distribuere, og samtidig er der en masse spændende muligheder ved at udgive noget på nettet. Så mit projekt flyttede sig fra at være et traditionelt hæfte til at være et debatskabende temaområde på Ugeskriftets hjemmeside.

Vinklen på projektet har også ændret sig. I begyndelsen var vægten i projektet på de forskellige aktuelle temaer inden for lægeverdenen, men efter at have gransket Gallupundersøgelser og fokusgruppeinterviews og lagt de resultater sammen med internettes muligheder, kom jeg frem til, at der er en meget stor vigtighed i, at fokusere på tilgængelighed og levende debat.

Hvis jeg sammenligner min oprindelige projektidé, og det, som projektet er blevet til, tror jeg meget mere på mit endelige projekt. Det er ikke fordi jeg ikke troede på mit projekt da jeg startede, men jeg har virkelig erfaret en masse ved at gennemarbejde et projekt fra A-Z, og jeg tror godt at dette projekt kan føres ud i livet – når redaktionen er kommet ovenpå efter vores kaotiske hjemmesideprojekt.

Ud over at selve slutproduktet og en del af mål og formål er blevet et andet, er der også tilføjet nye afsnit til projektet.

Det drejer sig om projektorganisation, tidsplan og evaluering af projekt og produkt, der alle er nye afsnit. Her udover er afsnittet om mål og afsnittet om ressourceforbrug blevet uddybet væsentligt.

Præsentation og reaktion fra interessant

Jeg præsenterede mit projekt, ved hjælp af NABC, for Ulrich E. Andersen, der er produktionsansvarlig og ansvarlig for økonomien på Ugeskriftet.

Han er ikke altid lige nem at imponere, men han skød på den anden side heller ikke projektet i sæk!

Efterfølgende fik jeg ham til at gennemlæse hele projektet, og så var han mere positiv stemt. Måske er min NABC så ikke skarp nok? Eller også er han typen der skal have alle fakta på bordet før han udtaler sig om noget?

Ulrichs største bekymring for projektet var, om adskillelsen mellem videnskab og ikke-videnskab vil være tydelig nok. Der er stadig en del læger der ikke mener at journalistik og videnskab hører sammen – men det er mest den ældre del af lægestanden.

Ikke desto mindre er det en væsentlig pointe som ikke nødvendigvis skal negligeres – Norges pendant til Ugeskrift for Læger (Tidsskrift for Den norske Lægeforening) har fx slet ikke journalistik.

Så et krav til layout og publicering skal være, at det er tydeligt adskilt, hvad der er videnskab og hvad der ikke er.

En anden kommentar var til min tidsplan. Her mente Ulrich – for de videnskabelige artiklers vedkommende – godt at jeg kunne fylde et par ekstra uger på!

Slutteligt bekymrede han sig selvfølgelig om økonomien. Der er, i sagens natur, ikke budgetteret med et tematillæg i det kommende år, men man kan måske finde nogle indtægter fra annoncer.

På den åbne del af Ugeskriftet.dk er der »almindelige« annoncer, mens der på den lukkede del, der kræver *login*, gerne må være annoncer for receptpligtig medicin. Her er altså en særlig mulighed for indtjening, og det er da en mulighed der skal undersøges!

Vurdering af modstand

Jeg tror ikke, at der vil være modstand mod projektet eller produktet som sådan, men der vil helt sikkert være modstand mod at arbejde mere.

Når man trækker ekstra arbejde ned over hovedet på folk, giver det som regel en eller anden form for modstand!

Den gruppe der erfaringsmæssigt kan give anledning til mest brok, er også en af de grupper der er sværest at inddrage yderligere i projektet. Jeg tænker her på vores sprog- og korrekturlæsere, der altid indleder en hver sætning med: »Det har vi ikke tid til ...«. Så her må man være forberedt på at tage nogle kampe, men i høj grad også at være forstående og evt. fjerne nogle af deres opgaver for en tid. Ofte hjælper det bare at lytte mens de får afløb for deres frustrationer.

Også journalisterne kan brokke sig en del, men her vil en løsning være at man slækker lidt på antallet af daglig opdateringer og nyheder på hjemmesiden, så der bliver bedre til tematillægget. Det kan måske også være en mulighed at trække en freelancer ind, eller bruge lidt »dåsemad« – altså artikler der ligger færdige og venter på at komme i bladet/på nettet.

Endelig kan jeg eller en sekretær, der ikke er på projektet, også tilbyde at lægge nogle artikler ind i vores redaktionsprogram, så journalisterne slipper for denne opgave.

Mit vigtigste våben mod brok og frustrationer, er at forholde mig positivt og imødekommende til alle kommentarer, spørgsmål og problemer. Det kan være sindssygt svært og rigtigt hårdt, men virker!